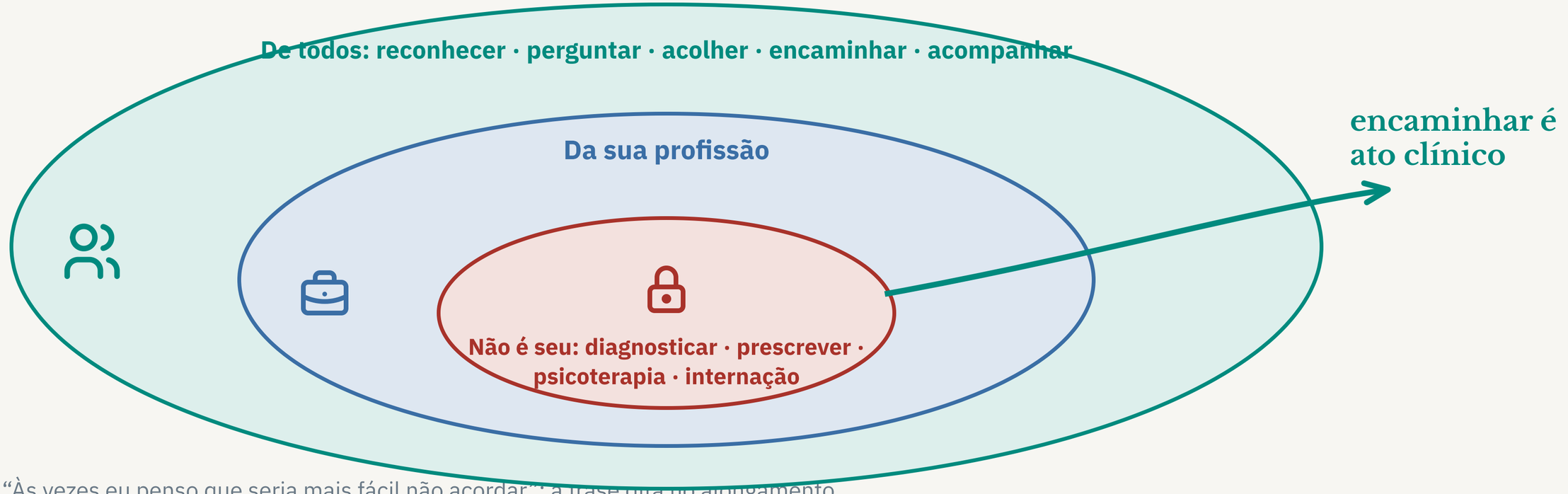
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Fluxo de encaminhamento

Da frase solta à consulta marcada

Psicologia do Esporte e Saúde Mental

Ninguém precisa saber conduzir para saber reconhecer



“Às vezes eu penso que seria mais fácil não acordar”: a frase dita no alongamento

PASSO ZERO: RECONHECER

A tentativa prévia é o sinal que mais pesa

- falas sobre morte, mesmo como piada
- desesperança
- despedidas e pendências resolvidas
- isolamento crescente
- mais álcool ou outras substâncias
- comportamento de risco novo

tentativa prévia

o fator de risco mais importante na população geral

O terreno

perda recente · lesão grave com afastamento longo · fim de carreira · humilhação pública · dívida · acesso a meios

Organização Mundial da Saúde · nenhum sinal é diagnóstico; todos são motivo para perguntar

A PERGUNTA QUE DESTRAVA

Perguntar não planta a ideia



o silêncio: é ele que produz dano

13

estudos, nenhum com aumento de ideação depois da pergunta

> “Você tem tido pensamentos de tirar a própria vida?”
>
> **sem eufemismo · com calma · olhando para a pessoa**

Revisão de 13 estudos, adultos e adolescentes, comunidade e grupos de risco · Psychol Med 2014

Quatro passos, na mesma ordem, sem improviso



1 · Fique

não deixe a pessoa sozinha; atrase o próximo treino se precisar

2 · Pergunte mais

como faria? tem acesso? hoje, nos próximos dias? já tentou?

3 · Acione

conforme a gravidade: o próximo slide

4 · Envolva alguém

“quem você prefere que eu chame?”

Não fazer: prometer sigilo antes de ouvir, minimizar, discutir razões para viver, deixar ir sozinha sem plano.

PASSO TRÊS: ACIONAR

A gravidade decide quem você aciona

Ideação sem plano

encaminhar · contato próximo · não deixar solto

Risco presente, sem iminência

prioridade no mesmo dia ou nos próximos · rede de apoio · menos acesso a meios · retorno marcado

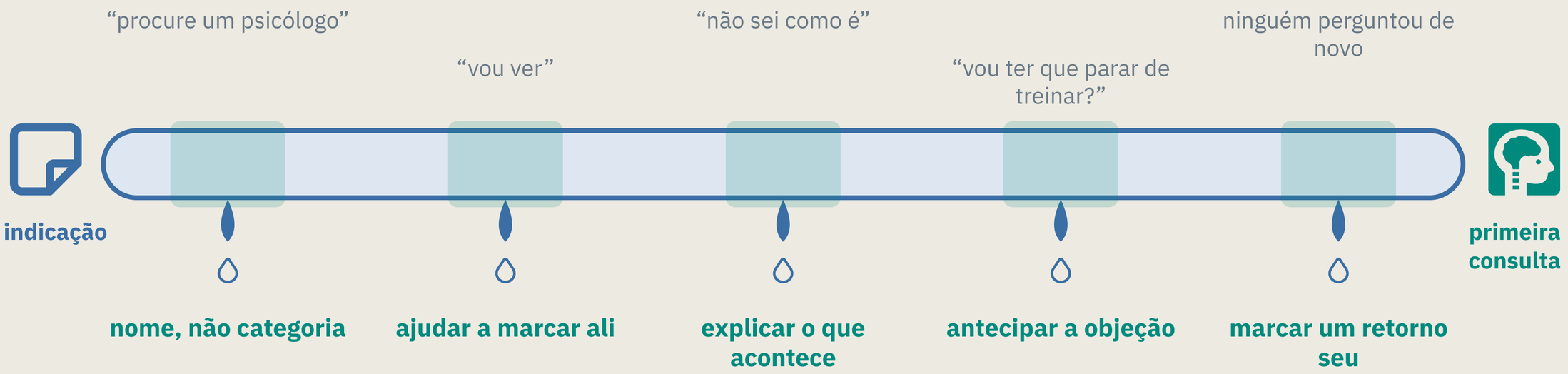
Risco iminente: plano, meio, intenção

emergência · ninguém sozinho · SAMU 192 · alguém de confiança

Em qualquer degrau: 188, Centro de Valorização da Vida · 24 horas · sem custo · sigilo

Rede pública: atenção básica, centros de atenção psicossocial e urgência e emergência são portas de entrada

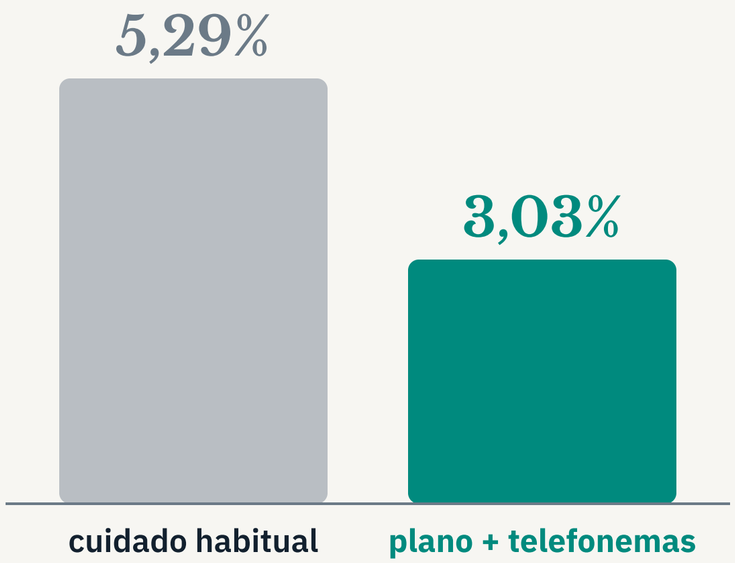
O encaminhamento se perde no caminho

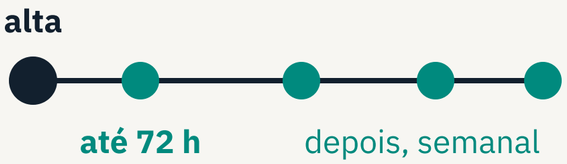


E o encaminhamento escrito com as cinco linhas do módulo de fundamentos.

Estudos de encaminhamento da atenção primária para saúde mental: comparecimento muito variável

O telefonema depois faz parte do cuidado





≈ 45% menos

comportamento suicida em seis meses, 1.640 pacientes

O plano de segurança

1. sinais de alerta da própria pessoa
2. o que ela faz sozinha
3. pessoas e lugares que distraem
4. a quem pedir ajuda
5. profissionais e serviços, um a qualquer hora
6. ambiente mais seguro, menos acesso a meios

Serviços de emergência de hospitais de veteranos, EUA · JAMA Psychiatry 2018 · quem monta o plano é o profissional de saúde mental

PRONTO ANTES DE PRECISAR

Monte o cartão hoje

Emergência

192 · 188 · pronto-socorro de referência

A sua rede

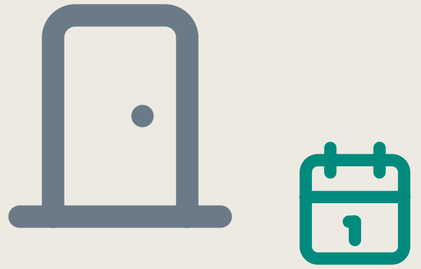
psicologia com quem já conversou · psiquiatria · transtorno alimentar

Rede pública

unidade básica de referência · centro de atenção psicossocial

As perguntas

ainda gosta de treinar? · tem se irritado mais? · o que mudou? · e a direta



A recusa não fecha nada

“Eu vou perguntar de novo daqui a um tempo, porque me importo com isso.”

E para quem cuida: não ser o único apoio de ninguém, ter com quem discutir casos, deixar claro o canal de urgência

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO

Da frase solta à consulta marcada

- Reconhecer, perguntar de forma direta, ficar
- A gravidade decide quem você aciona; o 188 vale em qualquer degrau
- Nome, marcação e retorno: o encaminhamento que chega

Quem treina e reabilita

Reconhece, pergunta, fica e encaminha com nome e telefone.

Médico

Avalia o risco clínico e aciona a emergência quando é emergência.

Psicologia e psiquiatria

Avaliam, tratam e montam o plano de segurança.